AXA · 데이터 2팀 · 진행 발표

메디대구 — 문제에서 사업 모델·화면 흐름까지

대구 등록 병원과 외국인 환자를 잇는 AI 의료관광 플랫폼 · 지금까지 정한 것

페인포인트
무엇이 막히나
근거 21건으로 후보 7개를 점수화 → **Top 3**

→

밸류체인
어디에 서나
5단계 네 층 맵, 병목 2·비용 2·기회 3 → **우선 기회 O1**

→

BM 캔버스 v2
누가 돈을 내나
12블록 캔버스 + 레드팀 3관점 21개 지적 → **v2**

→

시나리오·플로우·IA
어떻게 쓰나
As-Is → To-Be, 유저 스토리 7개, 예외 5개 → **MVP 범위**

주인공 (가정 페르소나)

린 — 29세 타이베이 직장인, 3박 4일 대구 여행 중 피부 시술 1회

왜 대만인가

대구 대만 환자 2025년 **1,495명**, 전년보다 **+500.4%**

우리 위치

"등록 외국인환자 유치사업자" 가정으로 설계·시연 (등록 전)

출처: painpoint/ · valuechain/ · bm/ · spec/ · 대만 환자 수: 한국보건산업진흥원 2025 외국인환자 유치실적 통계 (bm_canvas 1절 확인값)

① 페인포인트

린이 막히는 곳은 "고르는 단계" — 정보가 비어 있다

VOC 대신 데이터·공식·통계 근거 21건 + 가정 3건 · 점수 = 빈도 × 강도 × 해결 가능성 (최대 125)

후보	여정 단계	빈도	강도	해결	점수
Top 1 진료시간 정보 없음	② 비교·결정	5	4	4	**80**
Top 2 등록 병원 상세 부족	① 알아보기	5	3	5	**75**
Top 3 피부·성형 가격 기준 없음	② 비교·결정	5	4	3	**60**
보류 병원 응답 대기	③ 상담 예약	3	5	3	45
보류 귀국 후 단절	⑤ 귀국 후	3	3	3	27
보류 동의서 이해 · 예약 확인서	③·④		해결 1 (병원·제도 몫)		9 · 6

"병원 응답 대기"는 강도가 가장 높지만 환자 쪽 근거가 가정뿐 → 인터뷰 뒤 다시 봄

26.1% 진료시간 채움

대구 병원 월요일 진료시간 — 피부과 21.4%, 성형외과 14.1%. 플랫폼마다 표시 기준도 다름

13 / 145 상세 정보 있는 등록 병원

메디컬코리아 대구 등록 병원 중 통역 언어·진료시간 등 상세가 있는 곳

0곳 미용 시술 공공 가격

심평원 비급여에 의원급 미용 시술 가격 없음 → 플랫폼엔 병원이 정한 이벤트가뿐

출처: painpoint/painpoint_def.md · evidence.csv (E01 심평원 API · E02 심평원 비급여 · E03 메디컬코리아 CSV) · 점수는 팀 판정

② 밸류체인 · 팀 검토 반영

우리는 탐색·비교 → 상담 예약에 서고, 정산에서 돈을 받는다

산업 7단계 중 메디대구가 닿는 줄기를 5단계로 잘라 활동·이해관계자·돈·데이터 네 층으로 그림

	1 병원 데이터·입점	2 탐색·비교	3 상담 예약·확정	4 방문·진료	5 사후관리·정산
메디대구 기능	데이터 파이프라인 (심평원·메디컬코리아) · 병원 입점	**AI 챗봇** · 가격 위치 표시 · 5개 언어 지도	**상담 예약** · **병원 대시보드** (확정은 병원)	미포함 — 진료·체류는 병원 몫	사후관리 채팅 · 방문 완료 → **월 정산**
병목 · 비용	B1 진료시간 빈칸 (채움 26.1%)		B2 병원 응답 대기 [가정]		C1 병원 중개비용 중첩 · C2 요금 항목 분리 — 구독료(대시보드)와 유치 수수료(진료비 대비 %)는 별개
기회	★ O1 공공데이터 + **출처·확인일** — 경쟁사 중 출처를 내세우는 곳 없음	O3 수요 데이터 → 대시보드	O2 AI 요약·답장 초안 (코디 승인 후 발송)		

먼저 간다 **O1 공공데이터 + 출처·확인일**

데이터가 이미 있고(대구 병원 4,242곳) 환자가 떠나는 비교 단계를 메움. 단 빈칸 채우기가 먼저

빠른 성과 **O2 AI 답장 초안**

B2 대기를 줄이는 병원 쪽 도구. AI 도구 일부는 이미 구현

풀어야 할 것 **정산 근거**

건당 수수료의 기준(진료비·완납)은 병원만 앎 → 병원 건별 입력 + 환자 확인으로 맞춤

출처: valuechain/step4_네층맵.md · step5_분석.md (5-4 쟁점, 5-5 우선순위) · 검토요청 · 병원 수: 심평원 API

③ AX BM 캔버스 v2

쓰는 사람은 환자, 돈 내는 사람은 등록 병원 (양면 시장)

Top 1 아이디어: 진료시간·가격 범위·등록 여부를 출처와 함께 자기 언어로 → 챗봇으로 상담 예약 → 병원은 AI 초안으로 빨리 답함

핵심 파트너

- 심평원·공공데이터포털, 메디컬코리아, 행안부(폐업), 한국은행 ECOS
- LLM 제공자 (Gemini → Nemotron 자동 전환)
- 입점 병원 · 대구시·특구 **[가정]**

핵심 활동

- 데이터 갱신 → 진료시간 빈칸·미용 가격 직접 수집
- 챗봇 → 요청서 → AI 초안 → 코디 승인
- 입점 영업 · 월 정산

핵심 자원

- 공공데이터 가공본 (대상 1,267곳, 칸마다 출처·확인일)
- 유치업자 등록 (자본금·보증보험 각 1억 원 이상)
- 5개 언어 UI · 챗봇 도구 11개

가치 제안

환자 — 대구 병원의 진료시간·등록 여부와 **공공 자료가 있는 항목의 가격 범위**를 출처·확인일과 함께 내 언어로, 상담 예약까지 한곳에서

병원 — 외국어 상담 요청을 AI가 요약·번역·답장 초안으로 정리 → 빨리 답하고, 유입·전환·응답 시간으로 성과 확인

AI 역할마다 사람 검토 지점: 발송은 코디 승인, 확정은 코디, 진단은 의료진

고객 관계

- 환자: 셀프 + AI 챗봇 (병원 정보는 가입 없이, 챗봇·예약은 로그인)
- 병원: 셀프 대시보드 + 입점 온보딩

채널

- 환자 웹 (5개 언어·지도·챗봇)
- 병원 대시보드
- 메디컬코리아·병원 홈페이지 링크

고객 세그먼트

사용자 — 해외 거주 외국인 환자, 1순위 대만 미용·외래 단기 방문객 (국내 거주자는 정보 열람만)

지불자 — 대구 등록 유치의료기관 145곳 중 **외국어 문의를 직접 받는 피부·성형 의원** (유치업체 계약 여부 무관)

확보 병원·LOI 지금 0곳

비용 구조

고정: 등록 요건(자본금·보증보험) · 인건비 · 호스팅 | 변동: LLM 사용량 · 정산·CS · 빈칸 수작업 | 리스크: 동의·국외 이전, 법률 검토, LLM 요금 변경

수익원

주: 수수료 — 방문 완료·완납 1건 진료비의 % (월 정산) · 선택: **구독** (대시보드 이용료, 유치 수수료와 별개) · 보조: 일반 광고 배너 (병원 광고 아님)

출처: bm/bm_canvas.md v2 · bm/vpc.md · 등록 병원 145곳: 메디컬코리아 CSV · 등록 요건: 의료해외진출법 시행규칙 제4조

③ 수익모델 · 레드팀 검증

병원이 수수료·구독 중 하나를 고른다 — 대만 미용만으로는 손익분기에 못 미친다

금액은 모두 가정값 (확인값은 법정 상한·환자 수뿐) → 다음 시장 검증에서 숫자를 채움 · 계산은 다시 해서 맞는지 확인함

수익모델 — 입점 병원이 요금제를 고름

유형	판단
수수료 등록 병원	주 · 선택 B 방문 완료·완납 1건 진료비의 %, 월 정산. 온 환자에 대해서만 냄
구독 등록 병원	주 · 선택 A 대시보드(AI 요약·번역·지표) 월 이용료. 유치 수수료(진료비 대비 %)와 **다른 개념** — 환자 연결 대가는 넣지 않음
광고 일반 광고주	보조·나중 한국 화장품·관광 등, 병원 광고 아님

법정 상한: 유치 수수료 ÷ 그 환자 총 진료비 ≤ 의원 30% · 병원 20% · 상급종합 15% (확인값)

가격 가설 · 손익분기 (가정값으로 계산)

수수료: 방문 완료 1건 진료비의 **5~10%**, 기준 7% · 구독: **월 10만 ~30만 원**, 기준 20만 원

예상 방문	대만 환자 1,495명 × 미용·외래 80.3% × 경유 **10%** ÷ 12	**월 10건**
1건 이익	진료비 **50만** × **7%** − 변동비 **5천**	**3만 원**
손익분기	월 고정비 **275만** ÷ 3만	**≈ 92건**
구독 포함	(275만 − 병원 10곳 × 30% × 20만) ÷ 3만	**≈ 72건**
% 바꾸면	5% → 138건 · 10% → 61건	

→ 예상 월 10건의 **약 7~9배**가 필요 = 대만 미용만으로는 부족. 국적 확장 (대구 외국인 환자 2025년 19,243명)·진료과 확장이 먼저

레드팀 3관점 · 지적 21개

투자자 · 고객(환자·코디) · 경쟁사 역할의 AI 검토자 3명이 v1을 읽기 전용으로 공격, 지적마다 문서 문장을 인용

16	1	2	2
반영	일부 반영	추가 확인	보류·반박

처리 규칙: 치명 → 바로 반영 · 중요 → 반영 또는 확인 · 참고 → 보류 이유 · **두 관점이 같은 지적이면 한 단계 올림** · 근거 파일이 있으면 반박

- 월 40건은 대만 환자의 32% 경유 → 시장 식을 세워 **10건**으로
- 비용에 숫자 없음 → **손익분기 식** 추가
- "가격 범위"를 **공공 자료가 있는 항목만**으로 좁힘
- 지불자를 "외국어 문의를 직접 받는 의원"으로 좁힘

출처: bm/revenue_platform.md 1~3절 (재계산) · redteam_log.md · .claude/agents/redteam-*.md · 상한: 통합 고시 제2·3조 · 환자 수: 진흥원 통계 · 80.3%: 전국 대만 환자 피부과 비중

④ 서비스 시나리오 · 유저 플로우 · IA

린의 여정: 병원 찾기 → 예약 확정 → 귀국 후 사후관리까지 한 흐름

As-Is 장면마다 To-Be 화면 하나 · 필수 스토리 5개(US1~US5) = MVP 범위, 사후관리(US6)는 그다음 · 화면 이름은 지금 웹사이트 메뉴 그대로



예외 5개 · E0 조건 맞는 병원 없음 → 필터 해제 · E1 진료시간 없음 → "병원에 묻기" · E2 공공 가격 없음 → 숫자 안 지어냄 · E3 챗봇 미답 → 직접 상담 요청 · E4 국내 거주 → 예약 막음

As-Is (지금)	To-Be (메디대구)
등록 병원 중 상세 정보 13곳, 통역 언어 모름	번체 지도에서 등록 병원만 보고 언어 배지 확인
진료시간이 비어 있고 플랫폼마다 다름	요일별 진료시간 + 출처·확인일, 없으면 "병원에 묻기"
견적이 적정한지 비교 기준 없음	공공 자료가 있는 항목은 대구 범위 안 위치, 없으면 "자료 없음"
병원 LINE·메일로 따로 묻고 기다림	챗봇에 묻고 그 자리에서 상담 예약 요청
코디가 문의를 번역해 상담지를 손으로 작성	AI 요약·초안을 고쳐 승인 → 발송·확정
귀국 후 붓기가 걱정돼도 물어볼 곳이 마땅치 않음	사후관리 지원 병원이면 채팅으로 안내 (진료성 상담은 제도 시행 전 불가)

IA — 홈에서 세 번 이내

메인 › 병원 정보 › 병원 상세 · 가격 가이드 · 챗봇 · 상담/예약 · 마이페이지 › 예약 관리. 병원 정보·상세·가격은 **가입 없이**, 챗봇·예약은 **로그인**

질문: 배지 라벨 "등록 유치의료기관" → "외국인 환자 등록 병원"?

다음

- **시장 검증** — 유치업체 요율, 코디 인터뷰, 지불자 병원 수
- **MVP** — US1~US5, "요청 → 답장 → 확정" 장면
- 나중: US6 사후관리 · US7 방문 완료·정산

출처: spec/scenario.md · userflow.md · ia.md · 페르소나 린은 가정 · 근거 번호 E01~E16은 painpoint/evidence.csv